EXAMEN BLANC INFAS KORHOGO - SEPTEMBRE 2026
ÉPREUVE DE CHIRURGIE

Durée : 1 h 30 min - VERSION D

CONSIGNE : Répondez aux questions Q1 à Q60 en cochant la ou les bonnes réponses sur les alvéoles apprêtées à cet effet.

ATTENTION : Pour les QCD, une bonne réponse vous octroie un point et une fausse réponse vous retranche un point. Pour les QCM, chaque bonne réponse correspond à un point et une mauvaise retranche aussi un point au sein de l'item.

I - QCD (Questions à Choix Double)

Q1- La cryptorchidie est l'épanchement liquidien séreux entre les deux feuillets de la vaginale.

A- Vrai
B- Faux

Q2- Une dénivellation en marche d'escalier avec douleur exquise lorsqu'on palpe le membre est le signe d'une fracture de l'humérus.

A- Vrai
B- Faux

Q3- Une contusion abdominale par choc indirect se produit par percussion ou écrasement d'un organe contre la paroi abdominale postérieure.

A- Vrai
B- Faux

Q4- L'épreuve ultime au lit du malade est le dernier verrou de sécurité à respecter avant toute transfusion sanguine.

A- Vrai
B- Faux

Q5- Le signe de Psoas est la palpation douce du flanc gauche qui entraîne une douleur controlatérale au cours des appendicites aiguës.

A- Vrai
B- Faux

Q6- Sur les lieux d'un accident, l'infirmier peut tenter de réduire une fracture ouverte.

A- Vrai
B- Faux

Q7- Dans les traumatismes du bassin, lors d'un choc antéro-postérieur, un ou les deux hémi-bassins s'ouvrent en rotation externe.

A- Vrai
B- Faux

Q8- La fracture ouverte est une fracture qui communique avec l'extérieur par une plaie même minime.

A- Vrai
B- Faux

EXAMEN BLANC INFAS KORHOGO - SEPTEMBRE 2026
ÉPREUVE DE CHIRURGIE

Q9- La primo-infection tuberculeuse se fait par voie aérienne et peut se disséminer par voie sanguine vers d'autres organes parmi lesquels le rachis.

A- Vrai
B- Faux

Q10- Dans la majorité des cas de sciatalgie ou hernie discale, il s'agit d'un conflit disco-radiculaire.

A- Vrai
B- Faux

Q11- Devant un traumatisme crânien avec signe neurologique ou plaie pénétrante, un scanner est obligatoire d'emblée.

A- Vrai
B- Faux

Q12- Un traumatisé crânien qui ouvre les yeux de façon spontanée, répond aux piqûres du membre par le retrait et répond aux questions de façon appropriée a un Glasgow de :

A- 12
B- 13

Q13- On parle de traumatisme crânien grave lorsque le Glasgow est inférieur à 9 après correction des fonctions vitales.

A- Vrai
B- Faux

Q14- La hernie abdominale étranglée touche exclusivement les personnes de sexe masculin.

A- Vrai
B- Faux

Q15- Dans la hernie discale, le signe de Lasègue consiste à réveiller la douleur empêchant la poursuite du mouvement en soulevant progressivement le membre inférieur avec le genou tendu.

A- Vrai
B- Faux

Q16- L'abcès chaud est une collection purulente aiguë causée par le bacille de Koch.

A- Vrai
B- Faux

Q17- L'aplatissement du moignon de l'épaule, avec le coup de hache externe au tiers supérieur du bras est le signe de l'épaulette dans les luxations de l'épaule.

A- Vrai
B- Faux

Q18- La fracture de Pouteau-Colles est une fracture de partie distale du radius ou fracture juxta-articulaire.

A- Vrai
B- Faux

Q19- Dans la prise en charge des fractures, l'ostéosynthèse se pratique sous anesthésie générale.

A- Vrai

EXAMEN BLANC INFAS KORHOGO - SEPTEMBRE 2026
ÉPREUVE DE CHIRURGIE

B- Faux

Q20- La tuméfaction dans la hernie étranglée est dure, irréductible, tendue, expansive et impulsive à la toux.

A- Vrai

B- Faux

II - ÉTUDE DE CAS

Vous êtes infirmier diplômé d'État au service des grands brûlés du CHU de Cocody à Abidjan. À votre garde, vous recevez Monsieur Belem TINTO, 57 ans, domicilié au quartier Mossikro dans la commune d'Attécoubé et propriétaire d'une maison de transfert de devise. Il est aussi suivi pour diabète à l'INSP d'Adjamé. Il est reçu dans votre service pour brûlure par électrocution. L'examen clinique pratiqué par l'interne de service évalue les lésions à 35 % de la surface corporelle de M. TINTO selon la table de Lund et Browder. Pendant l'exploration des différents appareils chez M. BELEM, l'interne de service découvre une hypertrophie bénigne de la prostate. En outre, l'examen de laboratoire révèle un taux d'hémoglobine à 5 g/dl de sang.

En outre, M. BELEM demande avec insistance la présence de sa secrétaire particulière afin de lui donner des directives pour un meilleur fonctionnement de son entreprise.

L'interne institue une réanimation médicale basée sur le remplissage vasculaire de solutés avec une quantité estimée à 12 000 ml les deux premiers jours de la prise en charge en fonction de la surface corporelle brûlée.

Q21- La quantité de solutés indispensable à M. TINTO le premier jour selon Baxter est :

A- 4000 ml

B- 6000 ml

C- 8000 ml

D- 12000 ml

Q22- La quantité de solutés pour la réanimation de M. TINTO le deuxième jour selon Baxter est :

A- 4000 ml

B- 6000 ml

C- 8000 ml

D- 12000 ml

Q23- Le poids de M. TINTO est de :

A- 28 kg

B- 57 kg

C- 85 kg

D- 42 kg

Q24- Au cours de la première journée, les quantités de macromolécules, de glucosé et de bicarbonate à 14 p.1000 sont : (choisissez 3 bonnes réponses)

A- 3000 ml

B- 2000 ml

C- 6000 ml

D- 8000 ml

E- 4000 ml

F- 1000 ml

EXAMEN BLANC INFAS KORHOGO - SEPTEMBRE 2026
ÉPREUVE DE CHIRURGIE

Q25- Le débit du sérum glucosé isotonique 5 % (SGI) au deuxième jour sachant que toute la quantité doit passer en 8 heures est :

A- 62 gouttes/min
B- 83 gouttes/min
C- 160 gouttes/min
D- 46 gouttes/min

Q26- L'interne décide que le taux d'hémoglobine du client soit ramené à 10 g/dl de sang après la transfusion en 2 heures et demie. La quantité de sang envisagée selon le type de sang disponible à la banque de sang est : (choisissez 2 bonnes réponses)

A- 855 ml
B- 1050 ml
C- 3000 ml
D- 1800 ml
E- 2800 ml
F- 1710 ml

Q27- Les débits de la transfusion selon le sang utilisé seront de : (choisissez 2 bonnes réponses)

A- 171 gouttes/min
B- 100 gouttes/min
C- 85 gouttes/min
D- 70 gouttes/min
E- 280 gouttes/min
F- 140 gouttes/min

Q28- Le chiffre qui permet d'évaluer le pronostic vital chez M. TINTO selon la loi de Baux est :

A- 72
B- 107
C- 92
D- 84

Q29- Le pronostic vital selon la loi de Baux de M. TINTO est :

A- Guérison certaine
B- Mort quasi-certaine
C- 50 % de chance de guérir ou de mourir

Q30- Identifier trois (3) signes cardinaux qui ont permis la découverte de l'hypertrophie prostatique de Monsieur TINTO :

A- Anorexie
B- Pollakiurie
C- Dysurie
D- Céphalées
E- Rétention d'urine
F- Diarrhées

Q31- Formulez les diagnostics infirmiers en rapport avec la maladie et la situation sociale de M. TINTO. (Choisissez 2 bonnes réponses)

A- Besoin de respirer

EXAMEN BLANC INFAS KORHOGO - SEPTEMBRE 2026
ÉPREUVE DE CHIRURGIE

B- Besoin de manger et boire
C- Besoin d'éviter le danger
D- Besoin d'apprendre
E- Besoin de s'occuper de façon à se sentir utile
F- Besoin de se recréer

Q32- Donnez des diagnostics infirmiers se rapportant aux besoins non satisfaits relatifs à la prostatite de M. TINTO. (Choisissez 3 bonnes réponses)

A- Impossibilité de se mouvoir due à la douleur
B- Impossibilité d'émettre les urines liée à la rétention aiguë
C- Trouble du sommeil relié à la pollakiurie
D- Perturbation de la fonction nutritionnelle reliée à son état
E- Prédisposition aux infections reliée aux pertes incontrôlées d'urines
F- Risque de coma dû à l'adénome de la prostate

III - QCM (Questions à Choix Multiple)

Q33- Reliez chaque processus de survenue des occlusions intestinales à son mécanisme. (3 bonnes réponses)

Processus	Mécanisme
1- Occlusion organique	a- Obstruction
2- Occlusion dynamique	b- Strangulation
3- Occlusion mixte	c- Paralysie des muscles intestinaux
	d- Appendicite aiguë

A (1, c) ; B (2, a) ; C (1, b) ; D (3, b) ; E (3, d) ; F (2, c)

Q34- Reliez chaque mécanisme de survenue des occlusions intestinales à l'agent d'étranglement. (3 bonnes réponses)

Mécanisme	Agent d'étranglement
1- Obstruction	a- Fécalome
2- Strangulation	b- Invagination
3- Paralysie des muscles intestinaux	c- Volvulus
	d- Tumeur
	e- Hypokaliémie

A (1, d) ; B (2, c) ; C (1, b) ; D (3, e) ; E (3, d) ; F (2, a)

Q35- Les complications immédiates des fractures sont : (3 bonnes réponses)

A- Lésions vasculaires
B- Cals vicieux
C- Pseudarthrose
D- Choc hypovolémique
E- Lésions nerveuses
F- Ankylose

Q36- Le diagnostic positif de l'appendicite aiguë se fonde sur trois (3) de ces éléments, lesquels ?

A- Céphalées
B- Douleurs fosse iliaque droite

EXAMEN BLANC INFAS KORHOGO - SEPTEMBRE 2026
ÉPREUVE DE CHIRURGIE

C- Hématurie terminale
D- Recherche des douleurs provoquées
E- Pollakiurie
F- Hyperleucocytose à la NFS

Q37- Associez chaque type de fracture du fémur à son trait. (3 bonnes réponses)

Fracture du fémur	Trait de fracture
1- Fracture du col du fémur	a- Trait oblique, bas en dedans
2- Fracture du trochanter	b- Trait transversal, horizontal et vertical
3- Fracture de la diaphyse fémorale	c- Trait transversal, oblique avec un 3ème fragment osseux

A (1, c) ; B (1, b) ; C (3, a) ; D (2, a) ; E (2, b) ; F (3, c)

Q38- Dans l'examen somatique d'un traumatisé du bassin, quelles sont les associations qui ne sont pas vraies ? (2 bonnes réponses)

Symptôme	Lésion
1- Le malade urine beaucoup et facilement avec des urines claires	a- Rupture vésicale
2- Le malade urine beaucoup et facilement avec des urines sanguinolentes	b- Aucun organe touché
3- Le malade n'urine pas du tout et présence d'un globe vésical	c- Rupture de l'urètre
4- Le malade urine peu ou pas du tout et absence de globe vésical	d- Contusion rénale probable

A (1, b) ; B (2, d) ; C (4, a) ; D (2, b) ; E (3, c) ; F (3, a)

Q39- Parmi ces signes, quels sont ceux qui font suspecter un syndrome de WOLKMAN ? (3 bonnes réponses)

A- Sueurs froides
B- Œdème des extrémités
C- Cyanose
D- Tachycardie
E- Insensibilité du membre atteint
F- Pouls rapide, filant et imprenable

Q40- Le type de coma selon Glasgow chez un traumatisé du crâne qui n'ouvre pas les yeux, émet des sons incompréhensibles et fait des mouvements en extension à la douleur est :

A- Traumatisme crânien modéré
B- Traumatisme crânien dépassé
C- Traumatisme crânien grave
D- Traumatisme crânien bénin

Q41- Dans les fractures du fémur, le matin de l'intervention, les interventions infirmières se résument à trois (3) de ces activités, lesquelles ?

A- Faire la préparation psychologique
B- Administrer l'anesthésique
C- Réaliser le bilan préopératoire complet
D- Sonder le client sur prescription
E- Prévenir le chirurgien en cas de fièvre
F- Accompagner le client au bloc avec son dossier pour le rassurer

EXAMEN BLANC INFAS KORHOGO - SEPTEMBRE 2026
ÉPREUVE DE CHIRURGIE

Q42- Chez le traumatisé du membre supérieur, l'attitude Desault comprend trois (3) de ces signes, lesquels ?

A- Épaule abaissée, projetée en avant ; rapprochée de la ligne médiane
B- Abduction du bras et rotation externe
C- Tête inclinée du côté atteint et bras collé au corps
D- Aplatissement du moignon de l'épaule
E- Avant-bras semi-fléchi, soutenu par la main du côté opposé
F- Crépitation osseuse

Q43- Donnez trois (3) complications immédiates dans les polytraumatismes.

A- Complications urinaires
B- Hémorragies
C- Nécrose ischémique
D- Coxarthrose
E- Fractures associées
F- Ankylose

Q44- Indiquez trois (3) gestes à réaliser si vous vous retrouviez sur les lieux d'un accident.

A- Faire la prémédication
B- Baliser les lieux en vue de protéger le blessé
C- Transporter le blessé sur votre engin ou dans votre véhicule
D- Mettre en route une perfusion
E- Mettre le blessé en position latérale de sûreté ou sécurité
F- Faire une immobilisation provisoire

Q45- Parmi ces symptômes, indiquez trois (3) indications du drainage.

A- Dilatation des bronches
B- Appendicite aiguë
C- Méningite purulente
D- Cancer de la vessie
E- Pleurésies purulentes
F- Cavités infectées

Q46- Dans cette liste, indiquez trois (3) contre-indications de transfusion sanguine.

A- Hypertension artérielle
B- Diabète
C- Insuffisance rénale
D- Anémie chronique
E- Insuffisance cardiaque
F- Œdème aigu du poumon

Q47- La surveillance d'un appareillage de drainage consiste à trois (3) de ces activités, lesquelles ?

A- Vérifier la perméabilité du drain
B- Vider le contenu du bocal quotidiennement à heure fixe
C- Surveiller l'abondance de l'écoulement
D- Surveiller l'abondance et noter la quantité du liquide sur une feuille de température
E- Surveiller les paramètres vitaux
F- Vérifier la dépression créée par l'aspiration et la régler au besoin

EXAMEN BLANC INFAS KORHOGO - SEPTEMBRE 2026
ÉPREUVE DE CHIRURGIE

Q48- Trois (3) de ces tâches ci-dessous font référence à la préparation psychologique avant toute intervention chirurgicale. Ce sont :

A- Évaluer l'état physique, nutritionnel et biologique du client
B- Rassurer le client et le mettre en confiance
C- Prévenir et lutter contre l'infection
D- Procéder à la prémédication
E- Dissiper ses craintes de l'intervention ou même de la mort
F- Lui donner tous les détails de l'intervention

Q49- Deux (2) complications courantes de la péritonite sont sur cette liste, lesquelles ?

A- Hémorragie intra-abdominale
B- Occlusion abdominale
C- Septicémie
D- Ulcère gastroduodénal
E- Pancréatite aiguë
F- Salpingite

Q50- Trois (3) tâches en tant qu'infirmier auprès d'un opéré en salle d'hospitalisation après le bloc opératoire sont dans cette liste, lesquelles ?

A- Surveillance des paramètres
B- Évaluer l'état physique, nutritionnel et biologique
C- Préparer le champ opératoire
D- Administrer le traitement prescrit
E- Préparer psychologiquement la cliente
F- Surveiller la plaie opératoire et les drains

Q51- Les deux (2) buts du traitement de l'occlusion intestinale sont :

A- Lutter contre la fièvre
B- Rétablir la continuité du circuit intestinal normal
C- Lever l'obstacle
D- Alimenter le client
E- Corriger les désordres humoraux
F- Assurer une couverture antibiotique

Q52- Vous auriez à poser trois (3) gestes en tant qu'infirmier avant l'entrée d'un client au bloc opératoire. Lesquels ?

A- Demande de bilan sanguin
B- Procéder à la réanimation médicale
C- Pose de sonde nasogastrique
D- Faire le pansement
E- Pose de sonde urinaire
F- Absorption de la cavité abdominale

Q53- Indiquez deux (2) complications de la hernie étranglée dans cette liste.

A- Insuffisance rénale
B- Insuffisance hépatique
C- Occlusion intestinale
D- Appendicite aiguë
E- Péritonite aiguë

Q54- Au cours des contusions abdominales, le choc direct se produit par :

EXAMEN BLANC INFAS KORHOGO - SEPTEMBRE 2026
ÉPREUVE DE CHIRURGIE

A- Contrecoup produisant des lésions à distance des organes intra-abdominaux
B- Percussion ou écrasement d'un organe contre les vertèbres
C- En cas d'accélération ou décélération
D- Par effet explosif causé par augmentation soudaine de la pression intra-abdominale responsable de multiples lésions

Q55- Les signes fonctionnels des traumatismes cranio-encéphaliques sont : (choisissez trois bonnes réponses)

A- Perte de connaissance initiale ou coma d'emblée
B- Plaie
C- Douleur
D- Ecchymose
E- Amnésie
F- Hématome

Q56- Dans le traumatisme crânien modéré, le score de Glasgow est de :

A- 9 à 12
B- 13 à 15
C- 3 à 8

Q57- Dans cette liste, choisissez deux bonnes affirmations.

A- La monoplégie est la présence de mouvement d'intensité moindre
B- La paraplégie est une paralysie des deux membres inférieurs
C- La tétraplégie est une paralysie des quatre membres
D- La parésie est une présence de mouvement

Q58- Associez chaque type d'hémorragie cérébrale au type d'intervalle libre. (Choisissez 3 bonnes réponses)

Type d'hémorragie cérébrale	Type d'intervalle libre
1- Hémorragie épidurale	a- Long intervalle libre
2- Hémorragie sous-durale	b- Bref intervalle libre
3- Hémorragie intracrânienne	c- Absence d'intervalle libre

A (3, c) ; B (2, a) ; C (1, a) ; D (2, b) ; E (1, b) ; F (3, b)

Q59- Associez chaque type d'hémorragie cérébrale à l'origine du sang. (Choisissez 3 bonnes réponses)

Type d'hémorragie cérébrale	Origine du sang
1- Hémorragie épidurale	a- Sang artériel méningé
2- Hémorragie sous-durale	b- Sang veineux

EXAMEN BLANC INFAS KORHOGO - SEPTEMBRE 2026
ÉPREUVE DE CHIRURGIE

3- Hémorragie intracrânienne	c- Petites veines ou gros hématomes

A (3, c) ; B (2, a) ; C (1, a) ; D (2, b) ; E (1, b) ; F (3, b)

Q60- Ces signes sont ceux de la meilleure réponse verbale du score de GLASGOW, excepté deux (2), lesquels ?

A- Confuse
B- Spontanée
C- Appropriée
D- Flexion anormale
E- Incohérente
F- Incompréhensible

BONNE CHANCE À TOUS !!!

EXAMEN BLANC INFAS KORHOGO - SEPTEMBRE 2026
ÉPREUVE DE MÉDECINE

VERSION A

I - QUESTIONS À CHOIX MULTIPLES (QCM)

Hachurez les alvéoles correspondant aux bonnes réponses sachant qu'une bonne réponse vaut 1 point et une mauvaise réponse vaut 0 point.

Q1. Parmi les éléments suivants, indiquez la complication de la cirrhose du foie liée à l'hypertension portale :

A. Hépatite virale
B. Ictère grave
C. Abcès du foie
D. Ascite

Q2. Vous recevez SSS pour une sensation de faim douloureuse épigastrique évoluant par poussées, rythmée par les repas. SSS souffre de :

A. Gastrite
B. Reflux gastro-œsophagien
C. Pancréatite aiguë
D. Ulcère gastrique

Q3. L'un des signes cliniques suivants se rencontre dans l'insuffisance cardiaque gauche, identifiez-le :

A. Orthopnée
B. Œdème des membres inférieurs
C. Turgescence des jugulaires
D. Asthénie intense

Q4. La rage est une maladie infectieuse d'origine :

A. Parasitaire
B. Bactérienne
C. Mycosique
D. Virale

Q5. Laquelle des affections suivantes est une étiologie du reflux gastro-œsophagien ?

A. La gastrite
B. La sclérodermie
C. La régurgitation
D. Pancréatite aiguë

Q6. La période d'incubation lors de l'infestation par le virus de l'hépatite B est en moyenne de :

EXAMEN BLANC INFAS KORHOGO - SEPTEMBRE 2026
ÉPREUVE DE MÉDECINE

A. 15 à 45 jours
B. 50 à 150 jours
C. 30 à 100 jours
D. 15 à 90 jours

Q7. La contamination par le virus de l'hépatite B (choisissez la bonne réponse) :

A. Peut être faite par la voie digestive
B. Fait partie des infections non transmissibles
C. Peut être faite par l'eau polluée par le virus
D. Doit faire rechercher systématiquement une infection par le virus VIH et la syphilis

Q8. Parmi les maladies virales pouvant être transmises par voie sexuelle, on trouve principalement :

A. Hépatite à virus A
B. Hépatite à virus B
C. Hépatite à virus C
D. Hépatite médicamenteuse

Q9. Quelle est la proposition juste parmi les suivantes concernant l'asthme ?

A. L'asthme se manifeste par une dyspnée inspiratoire
B. L'asthme se manifeste par une dyspnée expiratoire
C. Cette dyspnée est à recrudescence diurne
D. Une toux est souvent associée à la dyspnée

Q10. La voie de contamination prédominante du sida est :

A. L'allaitement maternel
B. La voie sanguine
C. La voie transplacentaire
D. La voie sexuelle

Q11. La mise au point d'un vaccin contre le sida s'avère difficile car :

A. Le VIH est un rétrovirus
B. Le VIH s'attaque au système immunitaire de l'individu
C. Le VIH effectue des mutations fréquentes
D. Le VIH est différent d'un individu à l'autre

Q12. Le sida est une (cochez la bonne réponse) :

A. Pandémie
B. Épizootie
C. Épidémie
D. Endémie

Q13. Indiquez le signe clinique habituel de la dysenterie à Shigella (dysenterie bacillaire).

A. Fièvre
B. Diarrhée glaireuse, sanglante
C. Éruption cutanée
D. Ulcérations de la muqueuse colique

Q14. L'ensemble de signes qui caractérise mieux le syndrome dysentérique est :

A. Diarrhée aqueuse abondante accompagnée de vomissement et de déshydratation
B. Diarrhée graisseuse avec amaigrissement progressif
C. Diarrhée de selles pâteuses intermittentes avec douleurs abdominales diffuses
D. Diarrhée glairo-sanglante avec épreintes et ténesme

Q15. L'origine d'une hématémèse peut être :

A. La bouche
B. Le sigmoïde

EXAMEN BLANC INFAS KORHOGO - SEPTEMBRE 2026
ÉPREUVE DE MÉDECINE

C. Le gastre
D. Le côlon transverse

Q16. Méléna est une émission par l'anus de sang digéré :

A. Noir et fétide
B. Spumeux et fétide
C. Ocre et fétide
D. Rouge et fétide

Q17. L'expectoration est le produit des sécrétions :

A. Rhinopharynx
B. Pharyngées
C. Pulmonaires
D. Œsophagiennes

Q18. La colique désigne :

A. L'inflammation d'un organe creux
B. Les contractures répétées d'un organe
C. L'inflammation d'un organe plein
D. Les contractures répétées d'un organe creux

Q19. L'un des signes suivants peut être associé à un syndrome dyspepsique :

A. Le ballonnement
B. La diarrhée
C. La constipation
D. Le vomissement

Q20. L'épreinte est une :

A. Envie impérieuse d'aller à la selle avec douleur abdominale
B. Douleur intense de l'anus avec selles glaireuses
C. Dyspepsie accompagnée de fausses selles
D. Colique qui apparaît après l'évacuation du rectum

Q21. La colique néphrétique est une :

A. Douleur pénible de l'angle costo-vertébral et lombaire
B. Douleur de distension aiguë de la voie excrétrice
C. Douleur intense et paroxystique sus-pubienne
D. Douleur atroce vésicale et hépatique

Q22. La pollakiurie est une augmentation de la fréquence des mictions avec diurèse :

A. Augmentée
B. Diminuée
C. Conservée
D. Perturbée

Q23. Dans l'oligurie chez l'adulte, la diurèse est comprise entre :

A. 100 ml et 900 ml par 24 heures
B. 100 ml et 700 ml par 24 heures
C. 100 ml et 500 ml par 24 heures
D. 100 ml et 300 ml par 24 heures

Q24. L'hématurie est la présence de :

A. Hématies dans les urines
B. Bilirubines dans les urines
C. Leucocytes dans les urines
D. Hémoglobines dans les urines

Q25. La présence d'albumine dans les urines est la :

A. Pneumaturie
B. Myoglobinurie

EXAMEN BLANC INFAS KORHOGO - SEPTEMBRE 2026
ÉPREUVE DE MÉDECINE

C. Acétonurie
D. Protéinurie

Q26. Laquelle des affirmations suivantes est exacte ?

A. L'origine de la lésion, dans l'hématurie terminale, est rénale
B. L'origine de la lésion, dans l'hématurie initiale, est urétrale
C. L'origine de la lésion, dans l'hématurie totale, est prostatique
D. L'origine de la lésion, dans l'hématurie initiale, est urétérale

Q27. Une douleur thoracique déclarée par le client est un signe :

A. Objectif d'une pathologie respiratoire ou cardiaque
B. Physique d'une pathologie respiratoire ou cardiaque
C. Subjectif d'une pathologie respiratoire ou cardiaque
D. Paraclinique d'une pathologie respiratoire ou cardiaque

Q28. L'hémoptysie est du sang rouge qui survient après un effort de toux et qui provient de l'étage moyen :

A. Du larynx
B. De la glotte
C. De la trachée
D. Du pharynx

Q29. La dyspnée avec rythme respiratoire sans pause :

A. Inférieure à 16 cycles est une orthopnée
B. Inférieure à 10 cycles est une bradypnée
C. Supérieure à 10 cycles est une tachypnée
D. Inférieure à 16 cycles est une apnée

Q30. Les précordialgies cardiaques sont d'origine :

A. Psychosomatique
B. Ischémique
C. Neurologique
D. Pleuropulmonaire

II - CAS CLINIQUE

Vous assurez la permanence de nuit aux urgences médicales de l'EPHR de Korhogo avec le major. Vous recevez FFF, 54 ans, marié, père de 4 enfants scolarisés dans une école privée dont les inscriptions n'ont pas été faites à ce jour ; il est amaigri, présente un état d'hébétude avec quelquefois un délire. Son tableau est fait aussi de diarrhée faite de selles fétides d'aspect jus de papaye. La mesure des paramètres vitaux donne une température de 40 °C depuis plus de trois jours, ce qui a obligé l'infirmier à lui poser des vessies de glace. On note un pouls de 86 pulsations par minute. À l'ouverture de la bouche, vous constatez une langue saburrale (sale, pâteuse). Son épouse signale que FFF a été licencié de la SURCAF 2 où il occupait un poste de cadre supérieur. La maladie a débuté par des céphalées, des vertiges, l'insomnie avec un saignement endo-nasal. Le major vous pose les questions suivantes, auxquelles vous répondez :

Q31. Quelle affection retenez-vous après la collecte des données de FFF ?

A. Hépatite
B. Choléra
C. Fièvre typhoïde
D. Méningite

Q32. Quelle description principale justifie l'affection que vous avez retenue ?

A. Diarrhée de selles fétides d'aspect jus de papaye
B. Température de 40 °C depuis 3 jours et 86 pulsations par minute
C. Céphalées, vertige, insomnie, saignement endo-nasal

EXAMEN BLANC INFAS KORHOGO - SEPTEMBRE 2026
ÉPREUVE DE MÉDECINE

D. Diarrhée de selles fétides, céphalées, insomnie, température de 40 °C

Q33. Comment nommez-vous ce saignement ?

A. Hémoptysie
B. Épistaxis
C. Hématémèse
D. Hémosialorrhée

Q34. Quelle propriété est visée dans l'utilisation de la vessie de glace chez FFF ?

A. Antalgique
B. Hémostatique
C. Antipyrétique
D. Antiœdémateux

Q35. Identifiez l'agent pathogène de la maladie de FFF parmi les suivants :

A. Haemophilus influenzae
B. Bacille d'Eberth
C. Bacille de Klebs-Lœffler
D. Salmonella typhi

Q36. Indiquez les deux principales composantes de votre diagnostic infirmier selon le modèle conceptuel de Virginia Henderson (choisissez une seule réponse).

A. Objectif de soins et intervention infirmière
B. Problème d'indépendance et mots ou groupe de mots de liaison
C. Problème de dépendance et source de difficultés
D. Source de difficultés et problème d'indépendance

Q37. Lequel des éléments suivants est un mode de collecte de données dans la démarche scientifique en soins infirmiers ?

A. L'analyse des données
B. L'observation
C. Le plan de soin
D. L'objectif de soins

Q38. Relevez le diagnostic infirmier qui est en rapport avec la personne de FFF.

A. Altération de l'état nutritionnel liée à la maladie
B. Diarrhée liée à une infection digestive
C. Hyperthermie reliée à une infection sévère
D. Détresse psychologique reliée au licenciement et aux difficultés familiales

Q39. Choisissez entre ceux-ci l'objectif de soins prioritaire de FFF.

A. Assurer une surveillance rapprochée de l'état de conscience et des paramètres vitaux
B. Prévenir les complications neurologiques et circulatoires de l'hyperthermie
C. Ramener la température corporelle de FFF entre 36,5 °C et 37,5 °C
D. Assurer une alimentation équilibrée

Q40. Identifiez le besoin prioritaire de FFF parmi ceux-ci selon le modèle conceptuel de Virginia Henderson.

A. Éviter les dangers
B. Dormir et se reposer
C. Éliminer les déchets biologiques
D. Maintenir la température dans les limites de la normale

EXAMEN BLANC INFAS KORHOGO - SEPTEMBRE 2026
ÉPREUVE DE MÉDECINE

III - QUESTIONS À CHOIX DICHOTOMIQUE (QCD)

Répondre par A pour la proposition juste et B pour la proposition fausse.
Une réponse juste = 1 point ; une réponse fausse = -1 point ; une question sans réponse = 0.

Q41. Schistosoma mansoni est responsable d'une bilharziose intestinale et parfois hépatosplénique.

Q42. Devant un seul cas de choléra, l'IDE n'est pas obligé d'informer son supérieur hiérarchique.

Q43. Schistosoma haematobium est l'agent pathogène de la bilharziose uro-génitale.

Q44. Les serpents sont tous zoophages.

Q45. La plupart des serpents sont ovipares mais certains sont ovovivipares.

Q46. Dans les diabètes types 1 et 2, l'installation de la gangrène au pied est l'une des complications invalidantes et redoutables de ces affections.

Q47. L'une des complications de l'HTA est l'AVC ischémique.

Q48. La maturation des éruptions varicelleuses se fait comme suit : macules rosées, puis vésicules, puis croûtes en trois jours.

Q49. On parle de déshydratation moyenne lorsque la perte hydrique est inférieure à 5 % du poids corporel.

Q50. L'euthanasie est un droit du soignant.

Q51. L'OMS recommande avant tout traitement du paludisme de faire un TDR ou la recherche des plasmodiums par microscopie.

Q52. Le terme néphropathie gravidique « ajoutée » désigne les accidents gravidiques survenant chez les femmes atteintes d'hypertension ou de néphropathie préexistante.

Q53. Dans l'épreuve des trois verres, s'il y a du sang dans le troisième verre, l'hématurie est d'origine vésicale.

Q54. Le RAA est une maladie qui « mord le cœur et lèche les articulations ».

Q55. Une morsure de serpent n'entraîne pas toujours d'envenimation et celle-ci n'évolue pas inéluctablement vers la mort, même en l'absence de traitement.

EXAMEN BLANC INFAS KORHOGO - SEPTEMBRE 2026
ÉPREUVE DE PÉDIATRIE

VERSION D

QCD : Consignes

Une réponse juste équivaut à 1 point.
Une réponse fausse équivaut à -1 point.
Sans réponse équivaut à 0 point.

1. Dans les soins mère kangourou, la durée minimale du portage de l'enfant en discontinu recommandé est de 60 minutes.

A-Vrai B-Faux

2. La vérification et la mesure du résidu gastrique sont importantes avant le gavage chez l'enfant dont la sonde est déjà en place.

A-Vrai B-Faux

3. Le résidu gastrique supérieur au 1/3 de la ration administrée et propre signifie que la ration est trop importante pour l'enfant.

A-Vrai B-Faux

4. Résidu gastrique absent signifie que la quantité de la ration précédente administrée est insuffisante.

A-Vrai B-Faux

5. Le transport médicalisé est une des indications de l'incubateur.

A-Vrai B-Faux

6. Dans le carnet de santé mère-enfant, la partie réservée à l'accouchement concerne la 3ème partie.

A-Vrai B-Faux

7. Une absence de sourire social ou sourire-réponse à 3 mois ne doit pas faire objet de visite clé.

A-Vrai B-Faux

8. Le respect de la confidentialité fait partie des principes de remplissage du carnet mère-enfant.

A-Vrai B-Faux

9. L'enfant né à terme et correctement nourri triple son poids de naissance à 24 mois.

A-Vrai B-Faux

10. La croissance des os, la taille et le périmètre crânien sont les éléments qualitatifs de la croissance de l'enfant.

A-Vrai B-Faux

11. La section immédiate du cordon ombilical du nouveau-né après la sortie de la filière génitale expose celui-ci à une anémie ferriprive.

A-Vrai B-Faux

12. JR a 15 minutes de vie. Né à terme. Son poids de naissance est de 3 000 grammes. Dans le cadre des soins essentiels du nouveau-né, pour lutter contre la maladie hémorragique, je lui administre par voie orale 9 gouttes de vitamine K1.

A-Vrai B-Faux

EXAMEN BLANC INFAS KORHOGO - SEPTEMBRE 2026
ÉPREUVE DE PÉDIATRIE

13. Le collyre antiseptique administré au nouveau-né en salle de naissance a pour objectif de traiter une infection active de l'œil du nouveau-né.

A-Vrai B-Faux

14. Il existe trois types de toilette.

A-Vrai B-Faux

15. Avant la toilette, il faut appliquer du lait de toilette sur tout le corps du nouveau-né.

A-Vrai B-Faux

16. Lorsque la température corporelle de l'enfant dépasse 39 degrés Celsius, il faut lui donner un bain tiède.

A-Vrai B-Faux

17. Dans les soins ombilicaux, la solution ou le gel de Chlorhexidine s'applique sur le cordon frais de la pointe du moignon à la base du cordon.

A-Vrai B-Faux

18. Le pansement à la Chlorhexidine se fait une fois par jour jusqu'à la cicatrisation.

A-Vrai B-Faux

19. La fonction principale de l'incubateur est d'assurer la respiration d'un air filtré et humidifié.

A-Vrai B-Faux

20. Le colostrum qui est de couleur jaunâtre ou d'apparence claire et de consistance épaisse, constitue un excellent laxatif pour le bébé.

A-Vrai B-Faux

QCM : Cochez la ou les bonnes réponses

Une réponse juste donne 1 point.
Une mauvaise réponse donne 0 point.
Sans réponse équivaut à 0 point.

21. L'enfant ayant le marasme, présente les signes cliniques suivants :

A. Peau sèche, craquelée, et dépigmentée
B. Un visage creusé, vieillot avec un regard vif et intéressé
C. Anorexie-diarrhée-triste

22. Le diagnostic de certitude du paludisme repose sur :

A. La clinique seulement
B. La goutte épaisse ou le test de diagnostic rapide positif
C. La numération formule sanguine
D. La coloration des conjonctives

23. Pour rechercher les facteurs favorisant de la maladie chez l'enfant je m'appuie sur :

A. Le triangle pédiatrique
B. Le losange pédiatrique
C. La pyramide pédiatrique

24. Parmi les propositions suivantes deux ne sont pas des principes de la PCIMNE. Lesquels ?

A. Destinée aux agents de santé des ESPC
B. La gratuité
C. Approche syndromique
D. Approche systématique
E. L'efficacité

25. Le nouveau-né Téha est en bonne santé et nourri au sein. Il présente un écoulement blanchâtre au niveau de la vulve. Cet écoulement est appelé :

A. Leucorrhée blanchâtre
B. Crise génitale
C. Colostrum

EXAMEN BLANC INFAS KORHOGO - SEPTEMBRE 2026
ÉPREUVE DE PÉDIATRIE

26. Le nouveau-né normal a un âge gestationnel compris entre :

A. 37 et 41 semaines + 6 jours
B. 7 et 42 semaines + 6 jours
C. 38 et 42 semaines + 6 jours

27. Relevez la lettre correspondant aux différentes étapes de l'examen du nouveau-né :

A. Cotation d'APGAR, appréciation de la respiration du nouveau-né, mensurations, examen somatique par appareil
B. Cotation d'APGAR, appréciation du nouveau-né dans son ensemble, mensurations, examen somatique par appareil
C. Cotation des réflexes, appréciation du nouveau-né dans son ensemble, mensurations, examen somatique par appareil

28. Mienmo vient de naître il y a 1 mn. Elle présente une cyanose des extrémités, une fréquence cardiaque à 120 batt/mn, un cri vigoureux ? une attitude de WM, respiration irrégulière. Le score d'APGAR de Mienmo est égal à :

A. 5
B. 7
C. 8

29. Parmi le matériel de toilette cité ci-dessous, il y a un intrus : lequel ?

A. Une paire de moufles
B. Une brosse à dent
C. Du beurre de karité

30. Le bain thérapeutique est recommandé en cas de :

A. Fièvre
B. Dermatoses
C. Convulsions

31. Si la sonde est en place et que le résidu gastrique est supérieur au 1/3 de la ration et sale ; il faut trouver l'intrus dans les gestes à poser :

A. Faire un lavage gastrique
B. Sauter de repas
C. Injecter 20 cc de ringer lactate

32. Quelles sont les trois formes principales de malnutrition ?

A. Sous-alimentation, carences alimentaires, suralimentation
B. Obésité, diabète, hypertension
C. Kwashiorkor, marasme, obésité

33. Parmi les principaux symptômes, relever deux à rechercher chez l'enfant de 2 mois à -5 ans, dans la PCIMNE :

A. L'incapacité de boire ou de téter
B. La convulsion
C. La difficulté respiratoire
D. La léthargie
E. Le problème d'oreille

34. Dans la PCIMNE, deux de ces fiches utilisées correspondent à différentes tranches d'âge qui sont de :

A. 0 à 1 mois
B. 1 mois à 2 mois
C. 0 à 1 semaine
D. 1 mois à 6 mois
E. 2 mois à 5 ans

EXAMEN BLANC INFAS KORHOGO - SEPTEMBRE 2026
ÉPREUVE DE PÉDIATRIE

35. Mme DKT envoie au centre de santé, son nouveau-né présentant un muguet buccal. L'agent de santé décide de faire le soin de la bouche avec :

A. Du sérum glucosé isotonique
B. Du sérum bicarbonaté à 14 ‰
C. Du sérum glucosé à 10 %
D. De l'éosine aqueuse à 2 %

36. Vous recevez à votre permanence le nouveau-né Tahi au 5ème jour de vie, avec une pâte de médicament traditionnel sur le cordon ombilical. Vous décidez d'effectuer les soins ombilicaux en commençant :

A. De la base vers la pointe du moignon du cordon ombilical
B. De la pointe du moignon du cordon vers la base de l'ombilic
C. De la base vers la moitié du moignon du cordon

37. Parmi les dispositions suivantes, deux sont à observer par l'agent de santé avant les soins ombilicaux. Lesquelles ?

A. Ôter les bijoux
B. Habiller le nouveau-né
C. Porter un cache-nez
D. Remercier la mère
E. Noter le soin dans le carnet ou le dossier médical du nouveau-né

38. L'antiseptique recommandé pour les soins ombilicaux est :

A. L'Hexomidine
B. L'Éosine aqueuse
C. La Chlorhexidine gel

39. Pour affirmer qu'une gestante est bien suivie, il faut qu'elle réalise :

A. Au plus 3 consultations prénatales
B. Au moins 4 consultations prénatales
C. Au plus 2 consultations prénatales

40. Les soins essentiels du nouveau-né sont limités aux :

A. 5 premières minutes de vie
B. 60 premières minutes de vie
C. 90 premières minutes de vie

41. Dans la première heure de vie, il est nécessaire de mesurer la température du nouveau-né toutes les :

A. 10 minutes
B. 15 minutes
C. 20 minutes

42. La mise du nouveau-né au sein doit se faire précocement entre :

A. 0 et 15 minutes de vie
B. 15 et 30 minutes de vie
C. 30 et 60 minutes de vie

43. GG est né à 14 h 30 minute à terme. Il est en bonne santé apparente. Je mesure son poids et lui administre la vitamine K1 en IM entre :

A. 14 h 30 min et 14 h 45 min
B. 14 h 46 min et 15 h 00 min
C. 15 h 31 min et 16 h 00 min

44. Lorsque survient un granulome ombilical (bourgeon) après la chute du cordon, le geste approprié consiste à :

A. Continuer l'application de la chlorhexidine

EXAMEN BLANC INFAS KORHOGO - SEPTEMBRE 2026
ÉPREUVE DE PÉDIATRIE

B. Traiter avec du crayon au Nitrate d'argent
C. Appliquer de l'alcool à 90°

45. Les éléments de surveillance du nouveau-né dans l'incubateur sont :

A. Température ; Coloration ; poids ; Rythme cardiaque
B. Température ; Coloration ; Respiration ; Rythme cardiaque
C. Température ; périmètre brachial ; Respiration ; Rythme cardiaque

46. Parmi les signes suivants, relever les deux signes d'une prise de sein correcte sont :

A. La bouche de l'enfant à moitié ouverte
B. La joue de l'enfant touche le sein de sa mère
C. Les lèvres du nourrisson sont en éversion
D. L'enfant suce les deux tiers du mamelon
E. L'aréole de la mère est peu visible au-dessus du mamelon

47. Dans la physiologie de la lactation, la prolactine réalise les deux actions suivantes :

A. Augmente le taux d'œstrogène
B. Favorise la production du lait
C. Provoque la contraction des cellules alvéolaires
D. Réalise une action contraceptive chez la mère
E. Propulse le lait dans les différents canaux lactifères

48. Dans la physiologie de la lactation, la prolactine réalise les deux actions suivantes :

A. Augmente le taux d'œstrogène
B. Favorise la production du lait
C. Provoque la contraction des cellules alvéolaires
D. Réalise une action contraceptive chez la mère
E. Propulse le lait dans les différents canaux lactifères

49. L'âge recommandé par l'OMS pour l'ablactation chez le nourrisson est :

A. 6 mois
B. 12 mois
C. 18 mois
D. 24 mois

50. Un nourrisson de 4 mois est nourri au lait maternel et reçoit du PRIMALAN sirop depuis la naissance pour un problème d'allergie. La modalité d'alimentation de ce nourrisson est :

A. Allaitement exclusif
B. Allaitement prépondérant
C. Alimentation mixte

51. Au nombre des directives établies par l'OMS pour l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant dans le contexte du VIH, il y a :

B. La pratique et la durée de l'allaitement
C. La mise au sein tardive
D. Le choix systématique de l'alimentation de remplacement

52. Parmi les critères ci-dessous, relevez 2 critères qui justifient le choix de l'alimentation de remplacement :

A. Accessible
B. Fiable
C. Justiciable
D. Discutable
E. Durable

EXAMEN BLANC INFAS KORHOGO - SEPTEMBRE 2026
ÉPREUVE DE PÉDIATRIE

53. Pour préparer le bol de lait d'un nourrisson de 5 mois avec du lait infantile, indiquez la lettre correspondant à la bonne réponse :

A. 5 mesurettes rases de lait + 200 ml d'eau
B. 6 mesurettes rases de lait + 210 ml d'eau
C. 7 mesurettes rases de lait + 210 ml d'eau

54. Les SMK comportent 3 composantes essentielles. Parmi les propositions suivantes, indiquez celle qui n'est pas une composante des SMK :

A. Soins thermiques
B. Soins essentiels du nouveau-né
C. Allaitement

55. Domi est sous photothérapie, la surveillance de sa température se fait :

A. Toutes les 15 minutes
B. Toutes les 30 minutes
C. Toutes les 4 heures

EXAMEN BLANC INFAS KORHOGO - SEPTEMBRE 2026
ÉPREUVE DE SANTÉ PUBLIQUE

VERSION A — LICENCE 3 IDE / SFM — DURÉE : 1 h 30 min

ÉTUDE DE CAS 1

Vous décidez de mener une enquête sociodémographique et épidémiologique au sein du village Gbézou. Vous avez enregistré les informations suivantes :

Population totale de la localité au 31/12/2019 : 8 000 habitants.

Population totale de la localité au 1er/01/2021 : 8 400 habitants.

Pendant l'année 2022, les données sanitaires suivantes ont été relevées dans le village :

85 naissances dont 23 mort-nés ;

Nombre total de décès enregistrés dans la localité : 52.

08 décès dont 03 du tétanos néonatal dans la tranche de 0 à 7 jours ;

06 décès dans la tranche de 8 à 27 jours ;

1 à 11 mois : 09 décès dont 02 dus aux IRA, 05 au paludisme et 02 à la rougeole ;

12 à 48 mois : 15 décès dont 03 dus à la rougeole, 05 aux IRA, et 07 au paludisme ;

3 décès dus au paludisme ;

11 décès maternels dont 02 liés aux morsures de serpent, 03 ont lieu au 43ème jour après l'accouchement et 5 au 48ème jour après l'accouchement. Le reste est survenu avant le 43ème après l'accouchement.

À partir du texte ci-dessus, répondez aux questions en hachurant sur l'alvéole des lettres correspondantes aux bonnes réponses, sachant qu'une bonne réponse = 1 point et mauvaise réponse = 0 point.

Questions

1. Quel est le taux d'accroissement annuel de la population de Gbézou ?

A. 4,75 %
B. 5,00 %
C. 5,25 %
D. 6,00 %

2. Quelle est la population totale de Gbézou en 2021 ?

A. 8 820 habitants
B. 8 800 habitants
C. 17 640 habitants

3. Quelle est la population totale de Gbézou en 2022 ?

A. 8 820 habitants
B. 9 261 habitants
C. 9 725 habitants
D. 18 040 habitants

4. Quelle est la population moyenne de Gbézou en 2022 ?

A. 8 600 habitants
B. 9 041 habitants
C. 9 812 habitants

5. Quel est le taux brut de natalité de Gbézou en 2022 ?

A. 0,48 %
B. 0,58 %
C. 0,68 %

EXAMEN BLANC INFAS KORHOGO - SEPTEMBRE 2026
ÉPREUVE DE SANTÉ PUBLIQUE

D. 0,78 %

6. Quel est le taux brut de mortalité de Gbézou en 2022 ?

A. 0,48 %
B. 0,57 %
C. 0,67 %
D. 0,78 %

7. Quel est le taux de mortalité néonatale précoce de Gbézou en 2022 ?

A. 3,52 %
B. 4,83 %
C. 9,41 %
D. 12,90 %

8. Quel est le taux de mortalité néonatale tardive de Gbézou en 2022 ?

A. 7,05 %
B. 8,22 %
C. 9,67 %
D. 9,88 %

9. Quel est le taux de mortalité post néonatale de Gbézou en 2022 ?

A. 14,51 %
B. 12,23 %
C. 10,58 %
D. 9,46 %

10. Quel est le taux de mortalité néonatale de Gbézou en 2022 ?

A. 37,09 %
B. 27,05 %
C. 22,58 %
D. 16,47 %

11. Quel est le taux de mortalité infantile de Gbézou en 2022 ?

A. 37,09 %
B. 27,05 %
C. 41,93 %
D. 25,88 %

12. Quel est le taux de mortalité juvénile de Gbézou en 2022 ?

A. 0,93 %
B. 0,88 %
C. 0,97 %
D. 0,86 %

13. Quel est le taux de létalité lié au paludisme ?

A. 20 %
B. 23 %
C. 24 %
D. 25 %

14. Quel est le taux de mortalité maternelle ?

A. 1 612,90 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes
B. 8 064,51 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes
C. 10 756,34 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes
D. 17 741,93 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes

ÉTUDE DE CAS 2

Vous êtes en service dans le centre de santé Djamanasso dont la population de l’aire sanitaire est estimée à 6 500 habitants au 31 décembre 2024. Le taux d’utilisation du vaccin penta dans le centre est estimé à 98 %

EXAMEN BLANC INFAS KORHOGO - SEPTEMBRE 2026
ÉPREUVE DE SANTÉ PUBLIQUE

en 2024. Au terme des activités de l'année 2024, le taux de couverture annuel de vaccination du centre de santé chez les enfants de 0 à 23 mois a été estimé à 90 %.
Les données du tableau ci-dessous ont été enregistrées pour ce centre de santé en 2024.

Vaccins	**Nombre de doses administrées en 2024**
VPO 0	135
VPO 3	130
Penta 1	132
Penta 3	130
RR 1	120

À partir du texte ci-dessus, répondez aux questions en hachurant sur l'alvéole des lettres correspondantes aux bonnes réponses, sachant qu'une bonne réponse = 1 point et mauvaise réponse = 0 point.
Questions

15. Quel est le facteur de perte du penta pour le centre de santé de Djamanasso ?

A. 1,02
B. 1,11
C. 1,05
D. 1,17

16. Quel est l'effectif des enfants de 0 à 23 mois dans l'aire de santé de Djamanasso ?

A. 227 enfants
B. 408 enfants
C. 444 enfants
D. 456 enfants

17. Quel est le besoin théorique en penta pour ce centre en 2024 ?

A. 1 100 doses
B. 1 291 doses
C. 1 320 doses
D. 1 390 doses

18. Quelle est la population cible des enfants pouvant bénéficier du vaccin VPO en campagne pendant l'année 2024 ?

A. 1 400 enfants
B. 1 320 enfants
C. 1 300 enfants

19. Le taux d'abandon du penta pour le centre de santé de Djamanasso ?

A. 1,05 %
B. 1,75 %
C. 1,51 %
D. 2,24 %

20. Le taux d'abandon global de la vaccination au centre de santé de Djamanasso ?

A. 7,25 %
B. 9,09 %
C. 12,03 %

21. Quel est le nombre des enfants de 0 à 23 mois ayant été complètement vaccinés au CSR de Djamanasso en 2024 ?

A. 400 enfants
B. 422 enfants
C. 444 enfants

22. Quelle est la population cible des enfants de 9 mois à 14 ans pouvant bénéficier du vaccin RR en campagne pendant l'année 2024 ?

A. 1 300 enfants
B. 2 925 enfants
C. 2 325 enfants

EXAMEN BLANC INFAS KORHOGO - SEPTEMBRE 2026
ÉPREUVE DE SANTÉ PUBLIQUE

D. 1 756 enfants

QUESTIONS À CHOIX DOUBLE (Q.C.D)

Répondez aux assertions ci-dessous en choisissant sur l'alvéole A pour vrai et B pour faux.
Réponse juste = 1 point ; Réponse fausse = -1 point ; Pas de réponse = 0 point.

23. La proportion d'échantillons de selles prélevés dans les 14 jours après le début de la paralysie doit être supérieure ou égale à 80 %.

A. Vrai B. Faux

24. L'approche psychosociologique des besoins en vue du diagnostic communautaire permet de fournir les données quantitatives.

A. Vrai B. Faux

25. La confirmation du tétanos néonatale dépend d'une confirmation du laboratoire.

A. Vrai B. Faux

26. Le volet préventif basé sur une assistance médicale visant à lutter contre les grandes endémies d'où la notion de grandes endémies, est un volet sur lequel, la prestation des services était organisée pendant la période de 1960 à 1980.

A. Vrai B. Faux

27. Les soins dits essentiels lorsqu'ils portent sur les besoins prioritaires de l'individu, des familles et des communautés.

A. Vrai B. Faux

28. La confirmation d'une épidémie de rougeole, c'est lorsque cinq (05) cas suspects ou plus sont notifiés en un mois au sein d'une population de 100 000 habitants vivants dans un district sanitaire ou une aire de santé.

A. Vrai B. Faux

29. La règle des 3PS permet d'éviter les doses sacrifiées.

A. Vrai B. Faux

30. Les trois niveaux d'application des soins de santé primaires ont été dégagés pour booster la mise en œuvre des stratégies des SSP freinée par des difficultés.

A. Vrai B. Faux

31. Le taux de PFA est dit non poliomyélitique lorsque le nombre de cas de PFA est inférieur ou égal à 2 pour 100 000 enfants de moins de 15 ans.

A. Vrai B. Faux

32. La plupart des facteurs ayant des répercussions sur la santé se situent en dehors de l'influence du secteur sanitaire.

A. Vrai B. Faux

33. Les qualités d'une eau potable sont à la fois physiques et bactériologiques.

A. Vrai B. Faux

QUESTIONS À CHOIX MULTIPLE (Q.C.M)

Répondez aux questions ci-dessous en choisissant la ou les bonnes réponses.
Réponse juste = 1 point ; Réponse fausse = 0 point ; Pas de réponse = 0 point.

34. Les soins qui sont mis à la portée de tous, tant au plan géographique, social, financier que culturel sont dits :

A. Essentiels
B. Intégrés
C. Adaptés
D. Accessibles

35. L'un des principes de base des soins de santé primaire est :

A. La santé de la population
B. La couverture universelle

EXAMEN BLANC INFAS KORHOGO - SEPTEMBRE 2026
ÉPREUVE DE SANTÉ PUBLIQUE

C. L'efficacité du programme
D. La politique sanitaire

36. Les différents domaines de la surveillance épidémiologique sont :

A. Épidémiologie descriptive
B. Épidémiologie des maladies transmissibles
C. Épidémiologie analytique
D. Épidémiologie des maladies transmissibles
E. Épidémiologie évaluative

37. Parmi les différentes méthodes de correction des défauts physiques de l'eau, deux permettent de corriger la turbidité de l'eau. Lesquelles ?

A. Javellisation
B. Décantation
C. Ionisation
D. Sédimentation
E. Ébullition

38. Parmi ces critères, identifiez ceux qui sont pris en compte dans le choix d'une source d'approvisionnement en eau potable.

A. Salubrité
B. Profondeur
C. Débit
D. Coût
E. Vitesse

39. Le système d'évacuation des excréta sans entraînement de matières fécales est :

A. La fosse d'aisance
B. La latrine à fosse
C. La fosse septique
D. Le puits perdu

40. Parmi ces propositions suivantes deux ne sont pas les fonctions d'un système de santé. Lesquelles ?

A. La prestation de service
B. Promotion de la santé
C. La mobilisation des ressources
D. Le financement
E. Amélioration de l'état de santé
F. La gouvernance

41. Parmi ces formes d'accessibilité, deux sont dans le système de santé.

A. Accessibilité médicale
B. Accessibilité financière
C. Accessibilité géographique
D. Accessibilité socio-culturelle

42. Parmi ces propositions suivantes, une n'est pas un avantage de l'étude du milieu :

A. Connaître les différents problèmes de santé du milieu
B. Disposer des données fiables et récentes sur la population
C. Regarder, centrer son intérêt sur des points précis du milieu
D. Connaître les composantes de la communauté et son organisation sociale

43. Les facteurs physiologiques favorisant la santé sont :

A. Absence de troubles métabolique
B. L'aspect physique (poids ne correspondant pas à la taille, maigreur)
C. L'eau polluée ou non potable
D. Bonne aération
E. Environnement affectif satisfaisant durant l'enfance

44. Parmi ces propositions suivantes, un est un acteur de la mobilisation communautaire :

A. Organisation de jeunesse
B. Les gouvernements

EXAMEN BLANC INFAS KORHOGO - SEPTEMBRE 2026
ÉPREUVE DE SANTÉ PUBLIQUE

C. Les ministères
D. Organisations internationales

45. L'existence d'un goulot d'étranglement entre accessibilité géographique et l'utilisation des services signifie :

A. La population ne fréquente pas le service parce qu'elle n'accède pas
B. La population a accès au service, mais ne le fréquente pas
C. La population accède difficilement au service, mais le fréquente

46. Parmi ces éléments suivants, deux entrent dans l'élaboration d'une monographie :

A. Les informations relatives à l'agriculture et à l'alimentation
B. Les informations relatives à la politique
C. Les informations relatives à la culture
D. Les informations relatives à la faune
E. Les informations relatives aux marigots et cours d'eau

47. La période 1960 à 1980, identifiez le volet des activités de la santé parmi les propositions suivantes :

A. Un volet orienté sur les soins curatifs avec pour caractéristique essentielle, la gratuité des soins
B. Un volet orienté sur une émergence et une propagation des maladies fortement liées à la modernisation
C. Un volet orienté sur la promotion de la santé

48. Parmi les actions de prophylaxie, indiquez celles pratiquées en période coloniale :

A. Le dépistage des cas de maladies
B. Les consultations prénatales
C. L'isolement des cas dépistés
D. Les stratégies avancées
E. Les journées nationales de vaccination

49. Parmi ces propositions suivantes, deux sont celles ont marqué la période de 1994 à 2006 :

A. Une recrudescence et une extension des grandes endémies tels que le pian, la lèpre, la tuberculose, la dracunculose, l'ulcère de Burili
B. Le renforcement de la politique des médicaments essentiels génériques par le biais de la Pharmacie de la Santé Publique
C. La naissance d'un véritable système de santé national et d'une politique de santé
D. Le maintien en bonne santé la main d'œuvre destinée au développement économique qui était prioritaire
E. Une émergence et une propagation des maladies fortement liées à la modernisation de nos sociétés, à la modification des modes de vie, à l'urbanisation et aux difficultés d'adaptation et d'insertion

50. Parmi les propositions suivantes, identifiez l'avantage du diagnostic communautaire.

A. Permet d'identifier les principaux problèmes de santé d'une communauté avec sa participation et ses ressources pour envisager les solutions et des actions ciblées sur les problèmes repérés
B. Permet de faire une analyse fine des ressources disponibles (matérielles et humaine) sur le plan quantitatif et qualitatif
C. Permet de renforcer les activités effectuées en santé communautaire

51. Parmi les propositions suivantes, identifiez le but du diagnostic communautaire.

A. Permet de servir de base à toutes les actions sanitaires
B. Permet d'orienter les efforts sur les besoins réels de la population
C. Permet d'initier un processus de collaboration entre les populations et les agents de santé

52. L'existence d'un goulot d'étranglement entre l'utilisation des services et la couverture adéquate signifie :

A. La population vient une fois recevoir un soin, mais ne revient plus pour terminer la série de soins souhaitée pour avoir l'effet escompté
B. La population vient pour recevoir les soins mais n'y parvient pas
C. La population bénéficie des soins en quantité sans qualité

53. Parmi les critères suivants, indiquez ceux qui permettent de sélectionner un problème de santé :

EXAMEN BLANC INFAS KORHOGO - SEPTEMBRE 2026
ÉPREUVE DE SANTÉ PUBLIQUE

A. Population totale de la localité
B. L'ampleur du problème
C. La gravité du problème
D. Le niveau d'instruction des populations
E. La vulnérabilité du problème
F. La durée des interventions

54. Parmi les items suivants, identifiez celui qui est une population bénéficiaire de la mobilisation sociale.

A. L'individu
B. La communauté
C. La société toute entière

55. Parmi les items suivants, identifiez celui qui est une population bénéficiaire de la mobilisation communautaire.

A. La famille
B. Les personnes physiques
C. Les entités morales

56. Parmi ces propositions suivantes, un est un acteur de la mobilisation sociale :

A. Les partenaires de mise en œuvre (Organisation Non Gouvernementales)
B. Président de l'association de développement
C. Agent de Santé Communautaire

57. L'existence d'un goulot d'étranglement entre la population cible et la disponibilité des ressources signifie :

A. Les ressources sont disponibles mais la population cible ne s'y intéresse pas
B. Les ressources ne sont pas suffisantes pour satisfaire les besoins de la population cible
C. L'effectif de la population cible est très petit par rapport aux ressources disponibles

BONNE CHANCE